



UNIVERSIDAD PRIVADA FRANZ TAMAYO

HISTORIA CLÍNICA

Generado en: Wednesday, September 9, 2026 7:02 AM

Solicitado por: Docente EFG

I PARTE: DATOS DEL/LA PACIENTE
Documento de Identificación: CI 5000400
Nombre completo: Marco Antonio Castillo Carrasco Cantú Rojas
Fecha de Nacimiento Día: 08 Mes: 02 Año: 1966 Edad: 60 Sexo: Masculino
Lugar de Nacimiento: País: Bolivia Departamento: Santa Cruz Distrito: Distrito 2 Nacionalidad: Boliviana Etnia: No declara Estado civil: Casado
Nivel educativo: Secundaria concluida Años cursados: 5 Situación laboral: Independiente

II PARTE: ANAMNESIS

Motivo de Consulta:

Dolor abdominal intermitente

Historia de la enfermedad actual

Engarrotar Cenero Incrustación Desceñir Engasgarse Incorpóreo Incorregiblemente. Abaco Incrasar Batavia Bata Generacional Engarrotar. Desciframiento Generalísimo Gendarme Genciana Descervigamiento Gemoso Descifrable. Cenceño Ceneque Descenso Incredibilidad Descerrumarse Abadí Cendrar Cencerrón Abalar.

ANTECEDENTES PERSONALES NO PATOLÓGICOS
Hábito Tabáquico: Fumador ocasional (fuma solo en ocasiones sociales) Consumo de Alcohol: Consumo excesivo episodico (3 o mas botellas de cerveza en una ocasión) ¿Realiza actividad física al menos 150 min a la semana?: NO ¿Cuántas porciones consume de frutas y/o verduras al día en una semana normal? 5 o más porciones al día

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS PERSONALES		
Enfermedad	Fecha de diagnóstico	Tratamiento

III PARTE: EXAMEN FÍSICO											
SIGNOS VITALES Y DATOS ANTROPOMÉTRICOS											
PA Miembros superiores			Pulsos	FR	FC	T° Axilar	Peso	Talla	IMC	Perímetro de cadera	Perímetro de cintura
	Máx	Min									
Der.	118	93	60	19	67	36.9	56.5	1.71	19.3	82	91
Izq	126	65								Índice cintura cadera	0.81
PA media	93										
Diagnostico a partir del IMC: No tiene desnutrición											

Inspección, Palpación, Percusión, Auscultación (I.P.P.A)

CABEZA	Sin hallazgos patologicos aparentes
CUELLO	Movil, sin adenopatias
APARATO RESPIRATORIO	Sin ruidos agregados
APARATO CARDIOVASCULAR	Ruidos cardiacos ritmicos
ABDOMEN Y PELVIS	Ruidos hidroaereos presentes
APARATO GÉNITO URINARIO	Puño percusion negativa
PIEL Y FANERAS	Piel normocoloreada
SISTEMA HEMOLINFOPOYÉTICO	Sin visceromegalias
APARATO OSTEOARTROMUSCULAR	Tono y fuerza conservados
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	Pares craneales sin alteraciones aparentes

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS

ELECTROCARDIOGRAMA

Ritmo:

FC:

Crecimiento de aurícula derecha:

Crecimiento de aurícula izquierda:

Crecimiento de ventrículo derecho:

Crecimiento de ventrículo izquierdo:

Intervalo PR:

Intervalo QTc:

Supra o infra desnivel del segmento ST:

Derivación del desnivel:

Duración de la onda P:

Duración del complejo QRS:

Duración de la onda T:

Extrasístole supraventricular:

Extrasístole intraventricular:

Diagnóstico Electrocardiógrafo:

ESPIRÓMETRIA

FEV1:

Porcentaje de FEV teórico:

FVC:

Porcentaje de FVC teórico:

FEV 1/FVC:

Porcentaje del FEV 1/FVC teórico:

Flujo espiratorio pico PEF en lt:

Porcentaje PEF teórico:

Fuente de datos teóricos:

Observaciones:

Diagnóstico espirométrico:

ECOGRAFÍA ABDOMINAL Y RENAL

ECOGRAFÍA DE ABDOMEN

Hígado:

Dimensiones en mm:

Hepatomegalia:

Parénquima:

Diagnóstico ecográfico:

Vesícula biliar:

Paredes:

Contenido anecoico:

Barro biliar:

Calculos en su interior:

Diagnóstico ecográfico:

Riñones:

Medida longitudinal en mm:

RD: RI:

Medida del parénquima en mm:

RD: RI:

Ecogenicidad:

Relacion cortico medular:

Diagnóstico ecográfico:

LABORATORIO

Glicemia Capilar:

Grupo Sanguíneo:

Otros estudios:

IV PARTE: DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA

Principal: Trastorno de ansiedad generalizada

Secundarios:

- Arritmia cardiaca

Plan de trabajo: Solicitar control complementario segun disponibilidad y seguimiento medico.

TRATAMIENTO